הקבלה במרפאת טרום ניתוח

מה כותבים, איפה ואיך · תדרוך לסטאז׳רים ולמתמחים

1 תלונה עיקרית · 2 מחלה נוכחית · 3 מחלות רקע · 4 בדיקות · 5 ניתוחים · 6 תרופות · הדפסה וחתימה

על קוד של מתמחה
מציינים שהקבלה נכתבה על ידכם, כולל שם הסטאז׳ר/ית.

כל נושא ברובריקה שלו
בקמיליון: תרופות תחת תרופות, ניתוחים תחת ניתוחים.

לא משאירים לאשפוז
התורן בלילה עמוס. סוגרים הכול בטרום, כולל אק״ג.

בדיקה חסרה?
פקס למזכירת המחלקה: **08-9441790**

בסוף
מדפיסים וחותמים.

1 תלונה עיקרית

הופנה לניתוח _____ בשל _____ (האינדיקציה).

דוגמה: כריתת כיס מרה בגישה לפרוסקופית בשל אירועים חוזרים של דלקת.

2 מחלה נוכחית

- פותחים ב: **בן/בת XX, סובל/ת מ...** ומחלות הרקע בכותרות. הפירוט בהמשך.
- הדמיה (CT, MRI): עיקרי הפענוח עם תאריך. רק מה שרלוונטי, בלי העתק־הדבק.
- יש גרורות מרוחקות? **מדברים עם המתמחה.**
- ממצאי הבירור לפי סדר כרונולוגי.
- מי הכירורג שהפנה ומה האינדיקציה.
- מבקשים סיכום מרופא המשפחה. חוסך זמן בתרופות ובמחלות הרקע.

3 מחלות רקע: מפורט ויסודי

- **מחלת לב איסכמית:** צנתורים, אילו עורקים, מתי ואילו תרופות. אישור קרדיולוג לסיכון הניתוחי ולהפסקת נוגדי קרישה.
- **פרפור פרוזדורים:** הטיפול הקבוע. **אירוע מוחי:** מתי ומה.
- **מחלת ריאות:** סיכום רופא ריאות והתייחסות לסיכון.
- בכל מחלה: יש ייעוץ? מה הוא אומר? חסר ייעוץ? מציינים.
- עוברים על כל התיק ומכניסים את כל הייעוצים.

4 בדיקות טרום ניתוח

טבלת הבדיקות הנחוצות בסביסטון ונהלי המחלקה. הכול מ-3 החודשים האחרונים.

אק״ג	מפרטים. אין, או באיכות לא טובה? עושים שוב.
צילום חזה	אין פענוח? מסתכלים וכותבים. **יש CT חזה? לא צריך צילום.** מציינים ברובריקה.
דם	המוגלובין, טסיות, לויקוציטים, קריאטינין, Na, K, INR. לפי הצורך: סמנים, אלבומין, מדדי דלקת. תאריך ברובריקה.
לא עדכני?	מכתב לרופא המשפחה עם הבדיקות. המטופל מגיע איתן ליום הניתוח.

5 ניתוחים בעבר

- מתי, איזה ניתוח ובאיזה חתך (למשל אפנדקטומי לפרוסקופי או מקברני).
- לא ברשימה? כותבים "לטיפול הרשמת" ואת שם הניתוח בהערות.

6 תרופות קבועות

- **דיוק! מוודאים מול המטופל ומול הרשומות.**
- מינון, תדירות ודרך מתן.
- נוגדי קרישה (אספירין, קומדין, פלביקס, קלקסן ודומיהם): מתי הופסקו ולמה ניתנים.
- מסבירים למטופל מה ממשיכים ומה מפסיקים.

והכי חשוב: מפעילים שיקול דעת ושואלים את המתמחה בכל שאלה.

7 מה מוסיפים לפי תחום

בקעים

- לפי מכתב ההפניה: איזה בקע, איזה תיקון ומה האינדיקציה.
- בדיקה: שני הצדדים והטבור. צלקות קודמות. בגברים גם אשכים.
- שואלים על מתן שתן ונוקטוריה.
- בקע בצלקת: אילו ניתוחים ומתי.

בריאטריה

- מדד מסת גוף (BMI), מחלות רקע ואינדיקציה. עוברים על כל המפגשים במרפאה הבריאטרית.
- שיקוף בליעה, גסטרוסקופיה ו-TSH.
- בדיקות דם: ויטמינים, פריטין ועוד.
- ניתוח קודם כמו טבעת: לציין את הסוג (LAGB, SRVG).

שד

- מרפאת השד או מכתב ההפניה: אפיון הגידול ואינדיקציה.
- **צד ימין או שמאל: חשוב!**
- כרונולוגיה: פתולוגיה, סמנים, סימון מתוכנן (איזוטופים או תיל).
- טיפול נאו־אדג׳ובנטי, בדיקה גנטית ושיתוף פלסטיקאים.

קולון

- הערות המנתח.
- בירור סיסטמי: CT, צילום חזה, PET CT לפי הצורך.
- קולונוסקופיה ו-TRUS אם יש. פתולוגיה (כולל MMR, סמנים ו-MRI.
- טיפול נאו־אדג׳ובנטי והשיפור אחריו.

הפטוביליארי

- איזה ניתוח, התייצגות וסיבת הבירור.
- הבירור המקומי והסיסטמי לפי תאריכים. EUS ו-MRI: יחס לכלי דם.
- פתולוגיה ומרקרים. ניקוז דרכי מרה או ERCP.
- מעבדה: גם אנזימי כבד ובילירובין.

קיבה

- תוצאות גסטרוסקופיה ופתולוגיה.
- טיפול נאו־אדג׳ובנטי.
- תוצאות הבירור הסיסטמי (CT).

✓ לפני שמדפיסים

- ☐ תלונה עיקרית: ניתוח + אינדיקציה
- ☐ כל מחלות הרקע עם הייעוצים
- ☐ תרופות: מינון, תדירות ודרך
- ☐ נכתב ע״י: שם הסטאז׳ר/ית
- ☐ מי הכירורג שהפנה
- ☐ אק״ג, צילום חזה (או CT) ודם מ-3 חודשים
- ☐ נוגדי קרישה: מתי הופסקו
- ☐ אין שום דבר שנשאר לאשפוז
- ☐ הבירור לפי תאריכים
- ☐ כל ניתוח ברובריקה שלו, עם חתך
- ☐ הוסבר למטופל מה ממשיכים
- ☐ הודפס ונחתם